

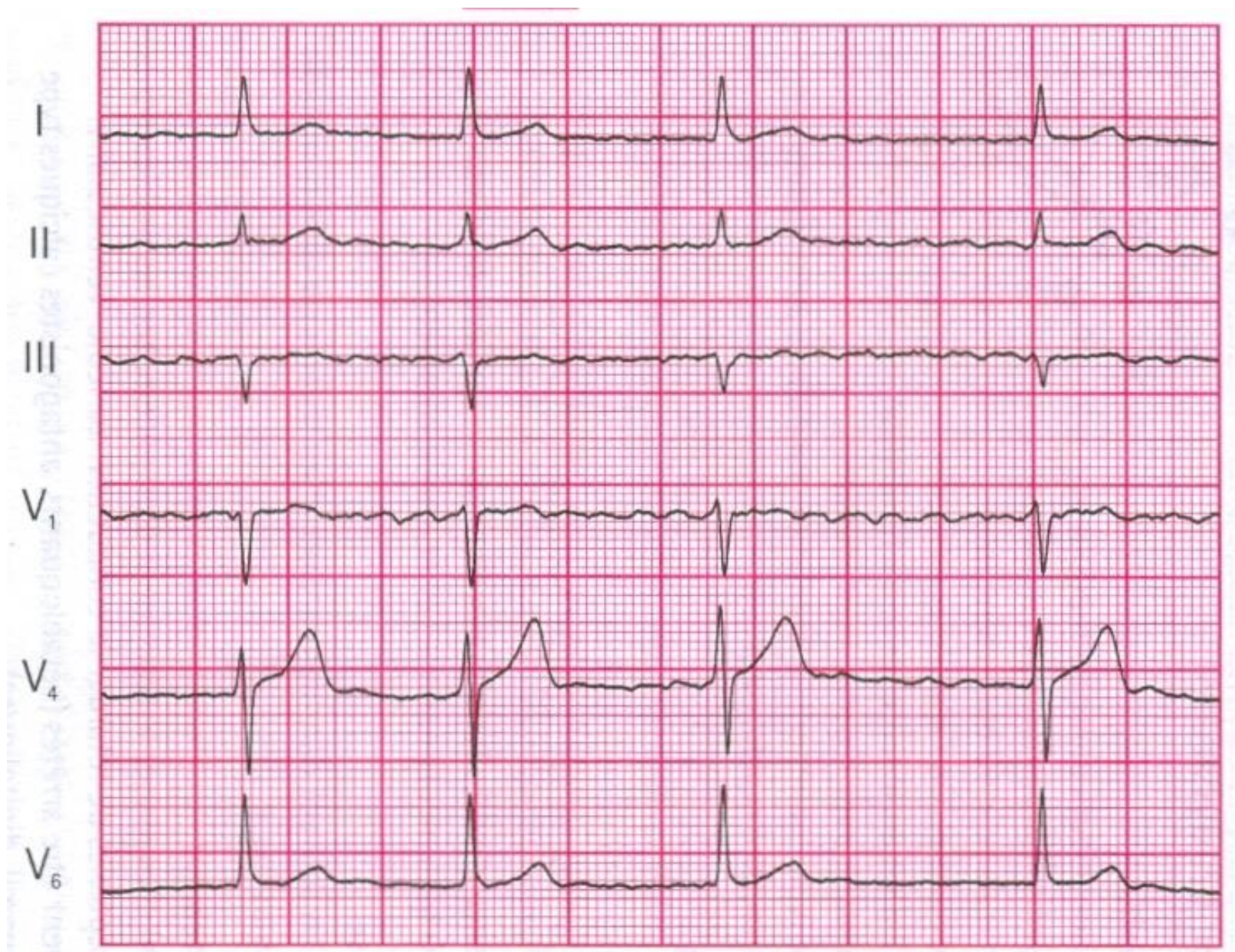
Vignette 1

Un patient présente subitement une crise de tachycardie bien supportée au plan hémodynamique. Tous ces troubles du rythme sont envisageables, sauf un : lequel ?

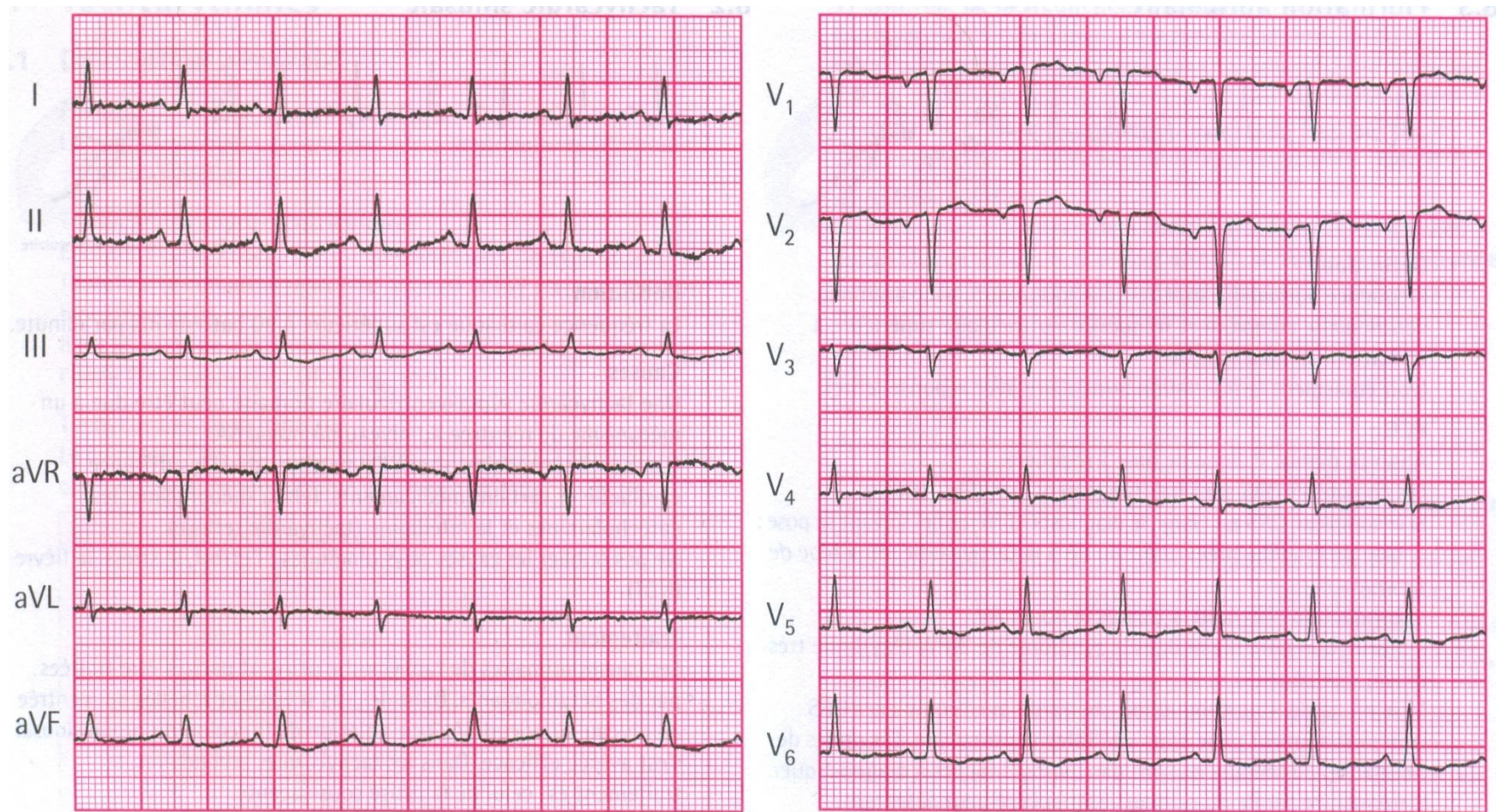
1. Fibrillation auriculaire paroxystique
2. Flutter auriculaire
3. Tachycardie nodale ou jonctionnelle
4. Fibrillation ventriculaire
5. Tachycardie sinusale

Réponse correcte

☐

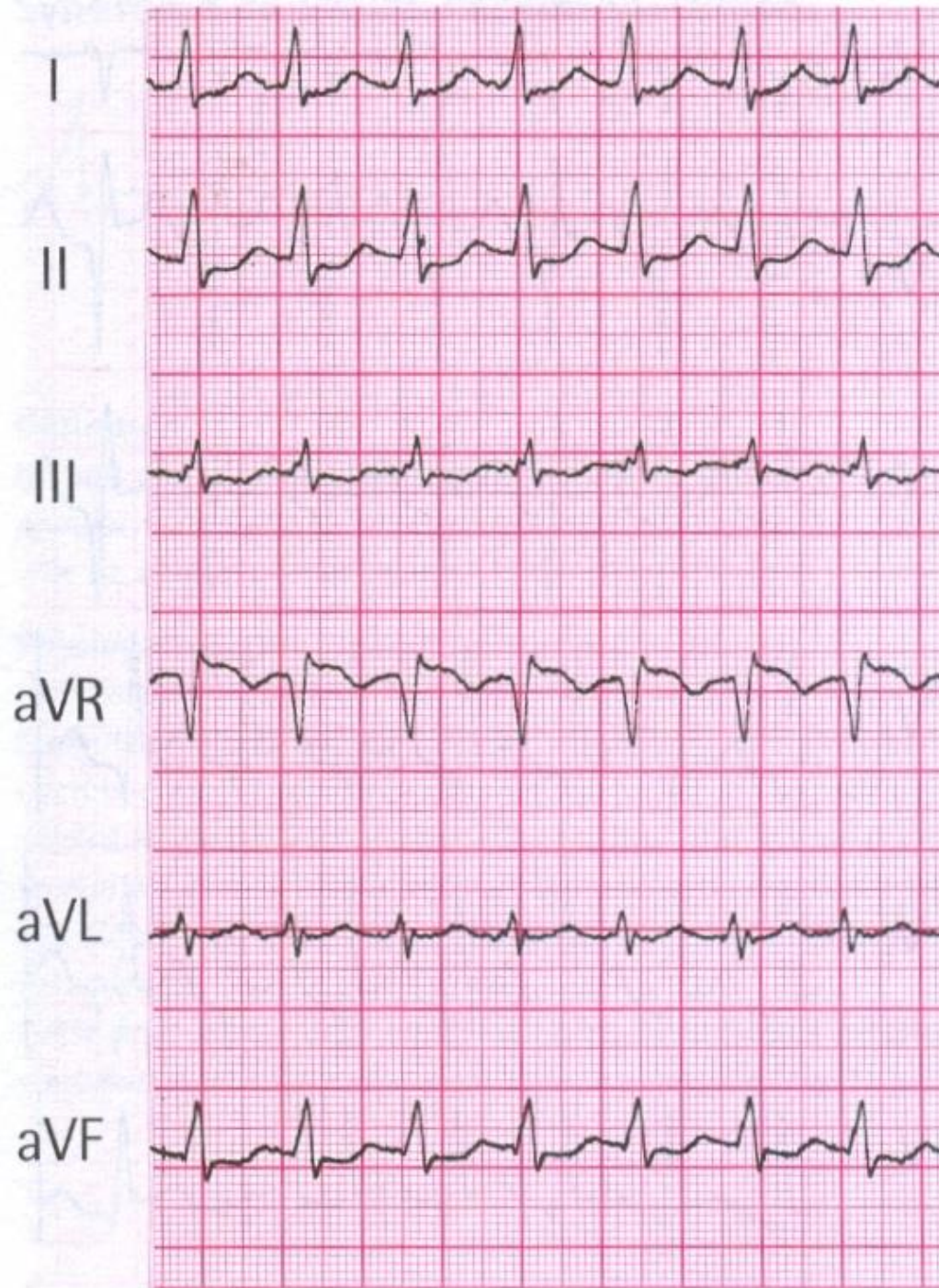


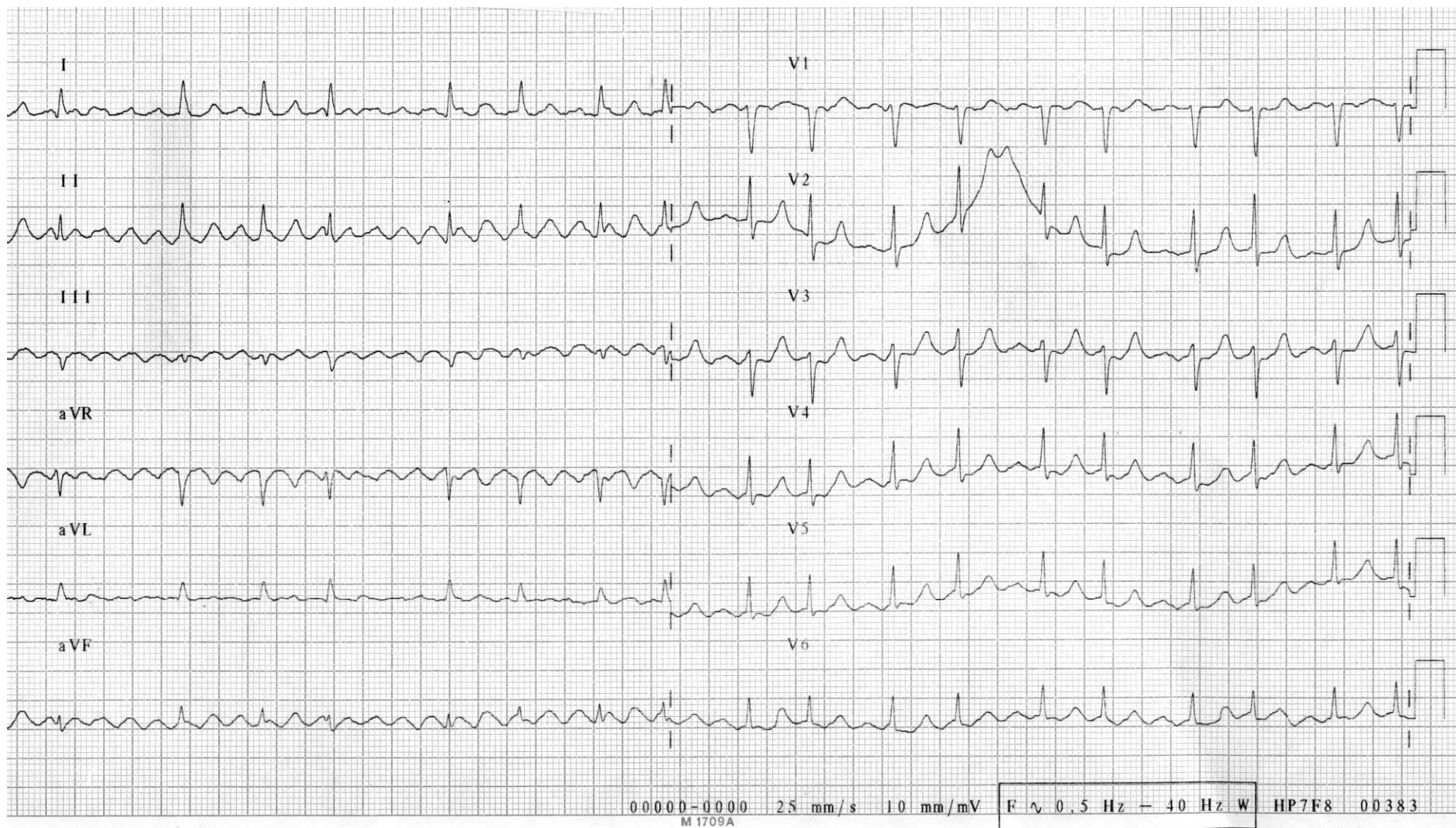
Fibrillation auriculaire



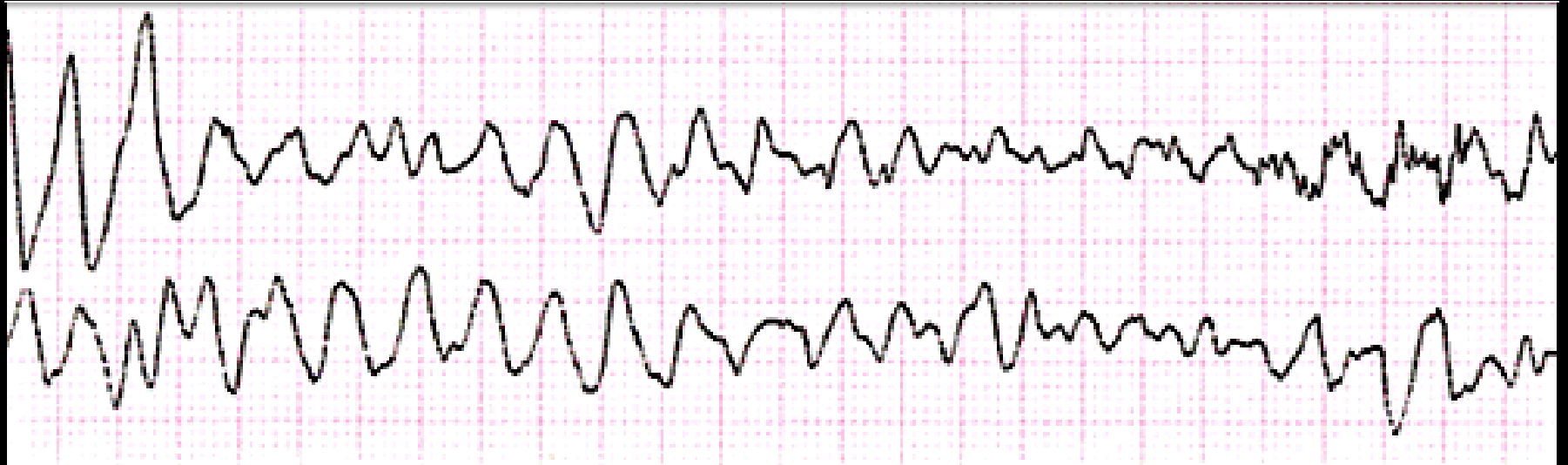
Tachycardie sinusale

Tachycardie
jonctionnelle





Flutter auriculaire



Fibrillation ventriculaire

Vignette 2

Un patient de 85 ans est hospitalisé pour une syncope. Il présente depuis plusieurs mois une dyspnée qui s'aggrave et des douleurs précordiales au moindre effort. On diagnostique une maladie aortique sévère. Tous ces signes cliniques sont compatibles avec cette valvulopathie, sauf un : lequel ?

1. Pulsus parvus, tardus et lentus
2. Souffle systolique
3. Frottement péricardique
4. Diminution du deuxième bruit cardiaque (B2)
5. Souffle diastolique

Réponse correcte

☐

Signes physiques

Frémissement à la palpation dans les formes sévères

Pulsus parvus, tardus et lentus

TA : pincement de la différentielle par abaissement de la PAS et conservation de la PAD

Souffle :

- Maximum au foyer aortique principal (2ème EIC droit)
- Irradie dans les carotides et l'apex
- mésosystolique, éjectionnel, losangique, rude, râpeux
- son intensité ne corrèle pas avec la sévérité de la sténose
- proto-mésosystolique = sténose légère à modérée
- se déplaçant dans la deuxième moitié de la systole = sténose sévère
- intensité diminue au Valsalva (DD avec la CMO)

Diminution, voir extinction de B2 = signe de gravité

Galop (B4)

Orifice valvulaire aortique

Orifice valvulaire aortique

Surface normale	: 2-4 cm ²
Sténose légère	: surface > 1.5 cm ²
Sténose modérée	: surface entre 1.0 et 1.5 cm ²
Sténose sévère	: surface < 1.0 cm ²

Meilleure quantification de la sténose si indexée

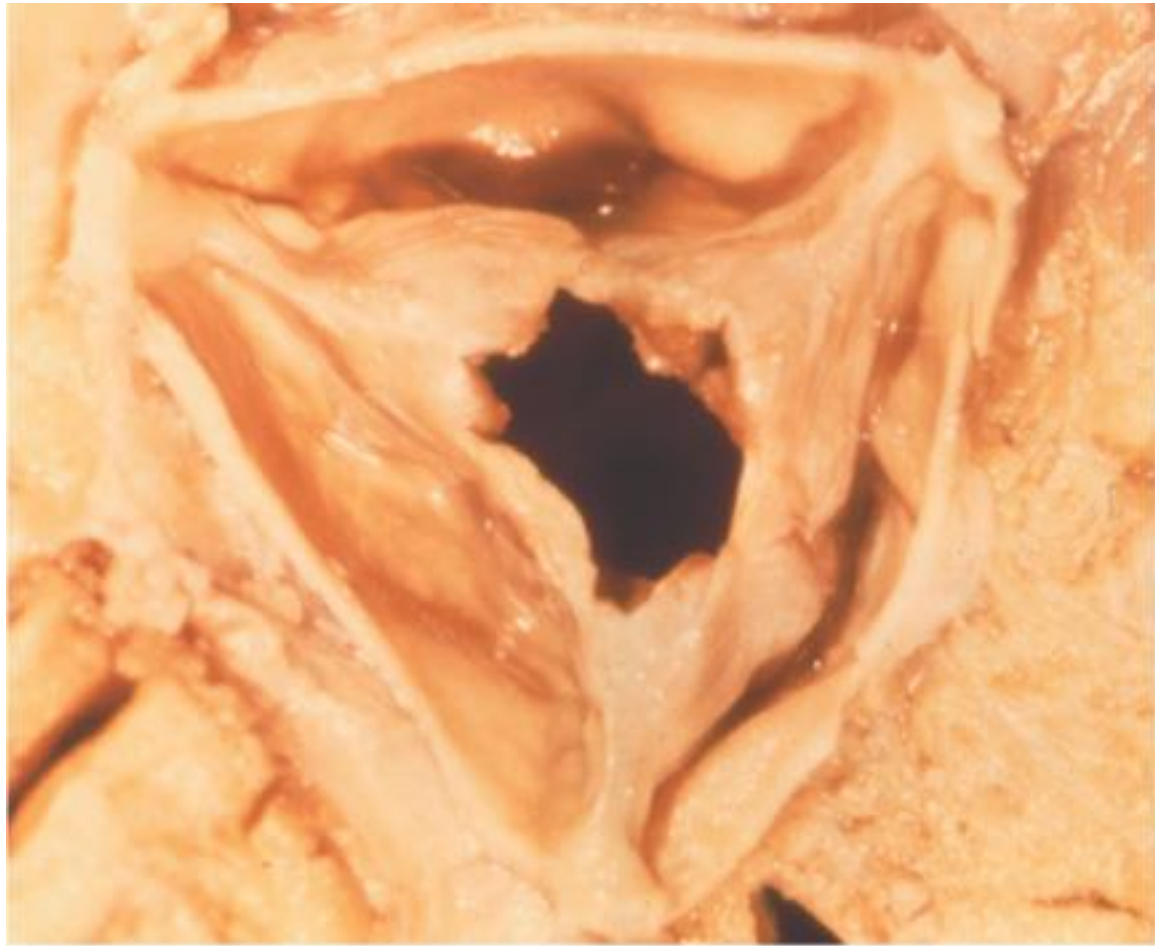
Sténose sévère	: surface < 0.6 cm ² /m ²
Orifice < 1.5 cm ²	: apparition d'un gradient de pression
Orifice < 1.0 cm ²	: augmentation de la pression VG (à contrôler)

Valve aortique tricuspide normale

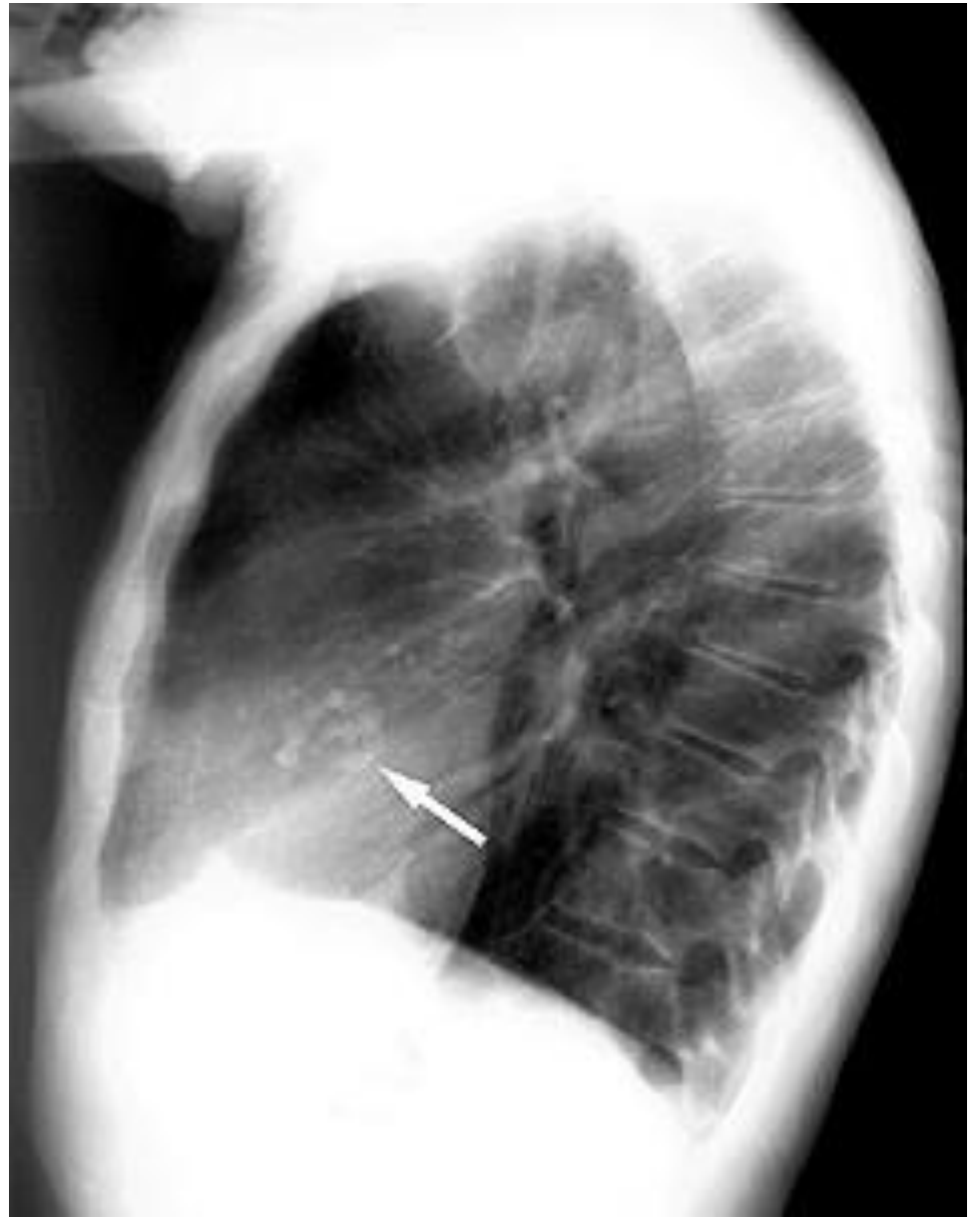
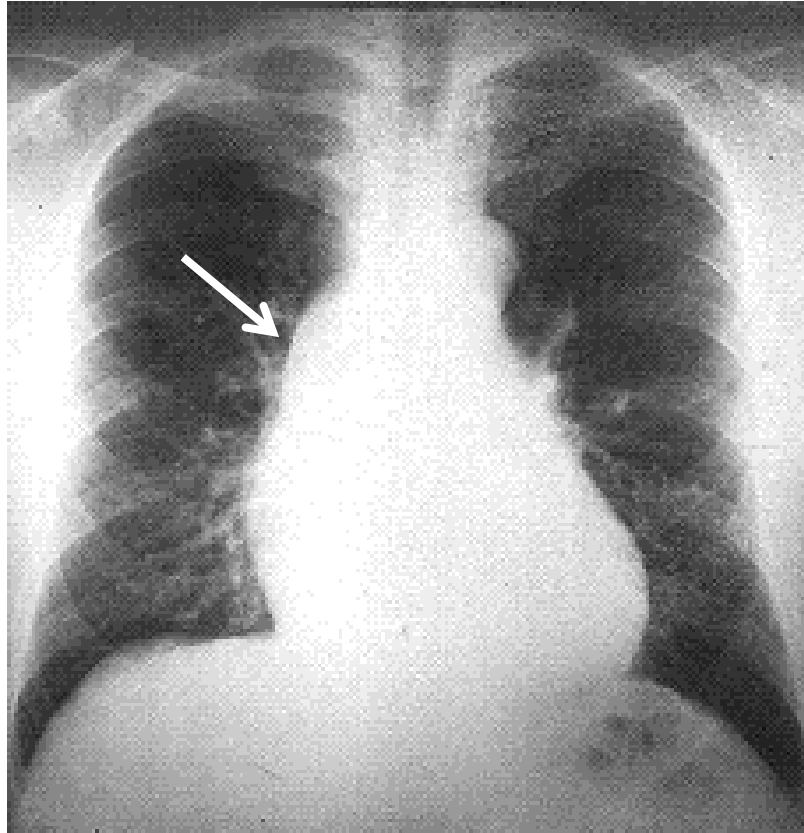


Surface normale de la valve : 2 – 4 cm²

Sténose aortique post RAA avec fusion des commissures



C



Vignette 3

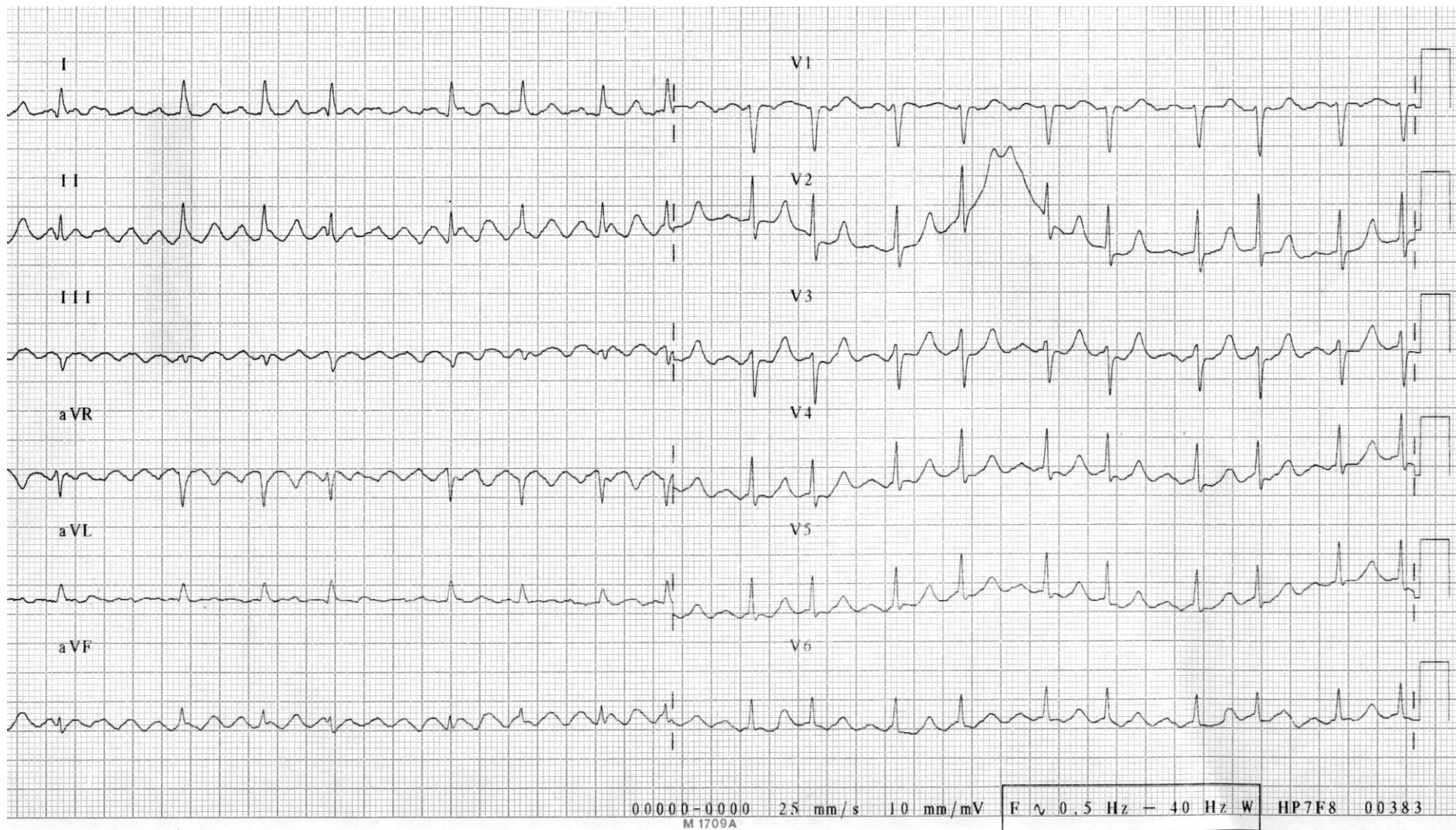
Un patient de 80 ans est sorti de l'hôpital il y a 3 jours après avoir été hospitalisé pour une décompensation cardiaque sévère. Tous ces médicaments font partie du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque systolique sauf un, lequel ?

1. Aldactone
2. Digoxine
3. Béta-bloqueur
4. Amiodarone
5. Inhibiteur de l'enzyme de conversion

Réponse correcte

☐

Vignette 4 - 1



Cet ECG montre :

1. Fibrillation auriculaire
2. Tachycardie auriculaire
3. Bloc AV du troisième degré
4. Flutter auriculaire à conduction variable
5. Tachycardie jonctionnelle

Réponse correcte

☐

Vignette 5

Un patient de 60 ans vient de quitter l'hôpital après un infarctus aigu du myocarde. Vous devez l'aider à contrôler ses facteurs de risque cardiovasculaire.

Tous sont des facteurs de risque, sauf un, lequel ?

1. Tabagisme
2. Sédentarité
3. Hyperhomocystinémie
4. Syndrome d'apnée du sommeil
5. Intolérance au gluten

Réponse correcte

☐

Vignette 6

Un patient sous traitement anticoagulant présente une baisse de l'état général, une hypotension artérielle, une dyspnée et une turgescence jugulaire.

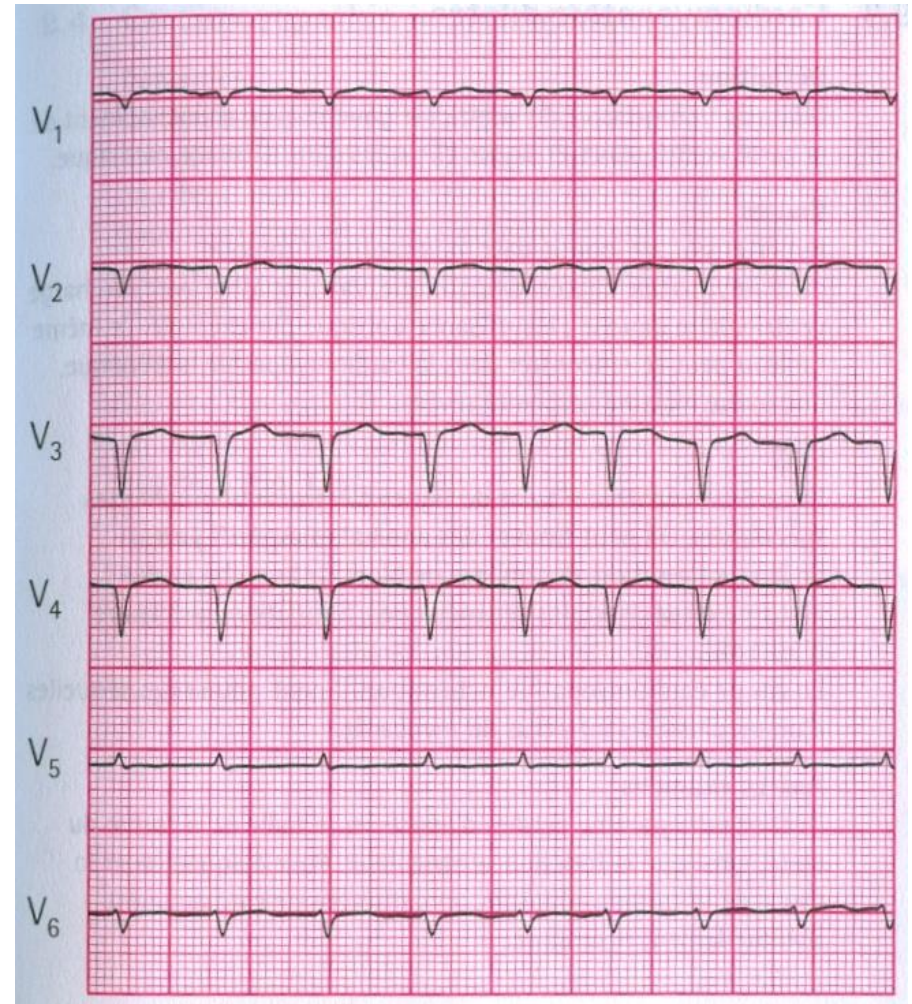
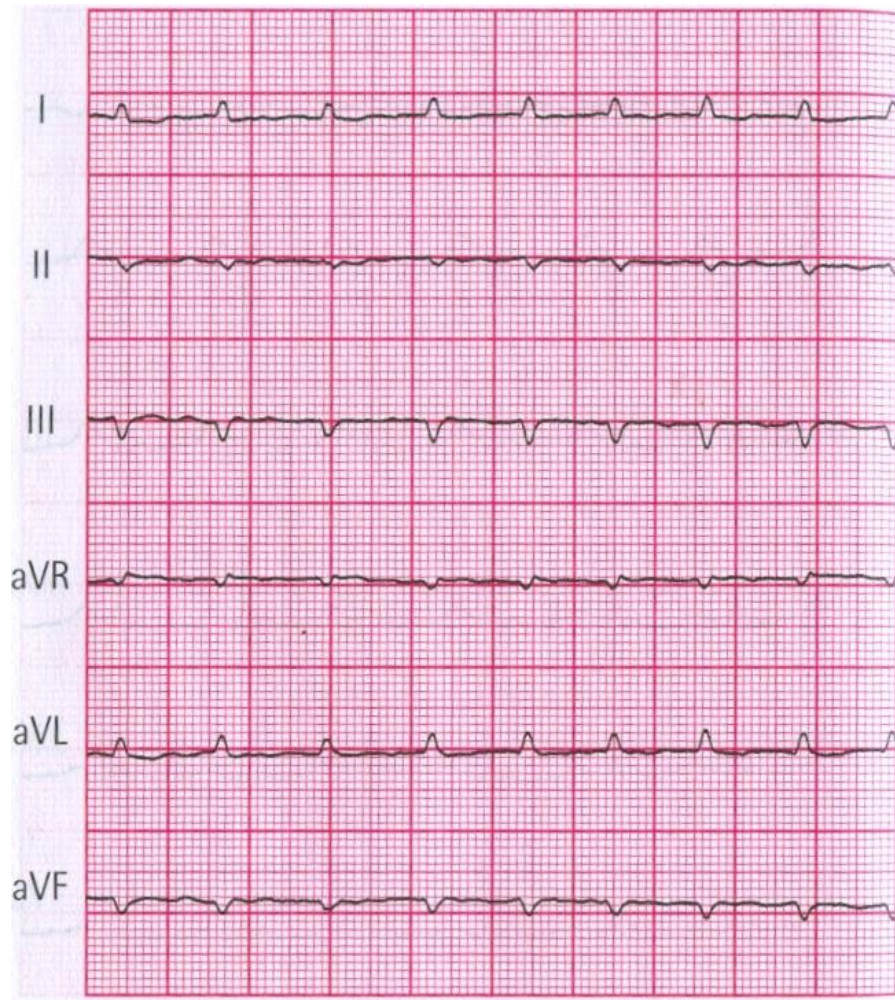
A l'auscultation cardiaque, les bruits sont diminués. Un ECG montre des micro-voltages dans les dérivations périphériques.

Quel diagnostic est le plus probable ?

1. Myocardite
2. Tamponnade cardiaque
3. Embolie pulmonaire
4. Sténose mitrale
5. Coarctation de l'aorte

Réponse correcte

☐



microvoltages

Vignette 7

Un patient de 45 ans présente des douleurs rétrosternales très intenses depuis 4 heures. On diagnostique à l'admission à l'hôpital un infarctus aigu dans le territoire antérieur. Le patient est hypotendu à 80 mmHg de systolique et bradycarde à 40 battements par minutes. Tous ces traitements sont corrects sauf un, lequel ?

1. Antalgie à la morphine sous-cutané
2. Aspirine 500 mg per os
3. Oxygène au masque
4. Nitroglycérine sublingual
5. Atropine intraveineux

Réponse correcte

☐

Vignette 8

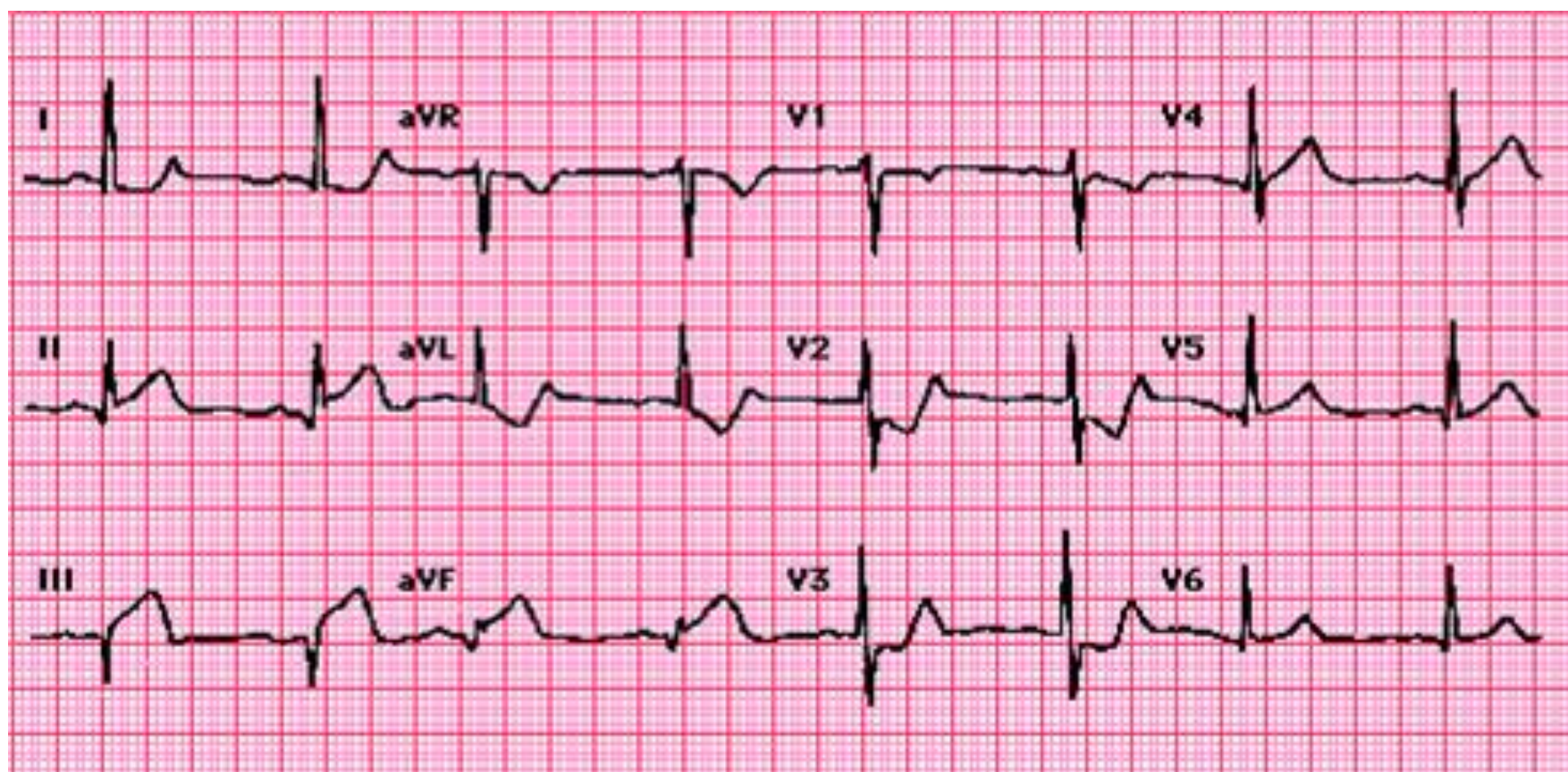
Un patient de 60 ans est admis à l'hôpital pour un infarctus aigu du myocarde dans le territoire inféro-postérieur.

Toutes ces modifications du tracé ECG correspondent à ce diagnostic, sauf une : laquelle ?

1. Onde Q en D2, D3 et aVF
2. Sus-décalage du segment ST en D2, D3 et aVF
3. Onde delta
4. Sous-décalage du segment ST en V1, V2
5. Grande onde R en V2

Réponse correcte

☐



Vignette 9

Vous pratiquez un ECG chez une patiente qui présente depuis plusieurs jours des palpitations continues. Le tracé montre la présence d'une fibrillation auriculaire. Toutes ces pathologies peuvent s'accompagner d'une FA sauf une, laquelle ?

1. Péricardite
2. Infarctus du myocarde
3. Embolie pulmonaire
4. Dissection de l'aorte abdominale
5. Hyperthyroïdie

Réponse correcte

☐

Patiente de 30 ans.
Peu de symptômes.
Radiographie de routine.
A l'ECG :
- PR > 0.20 sec
- BBD incomplet
- HBAG
- QRS > 0.12 sec en V1



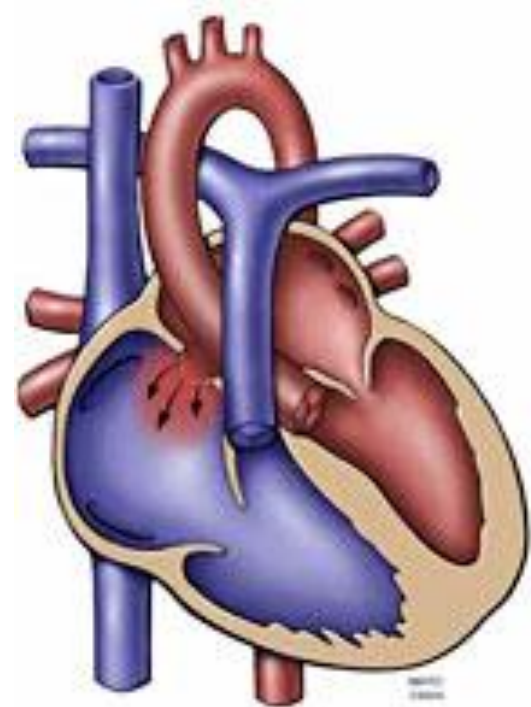
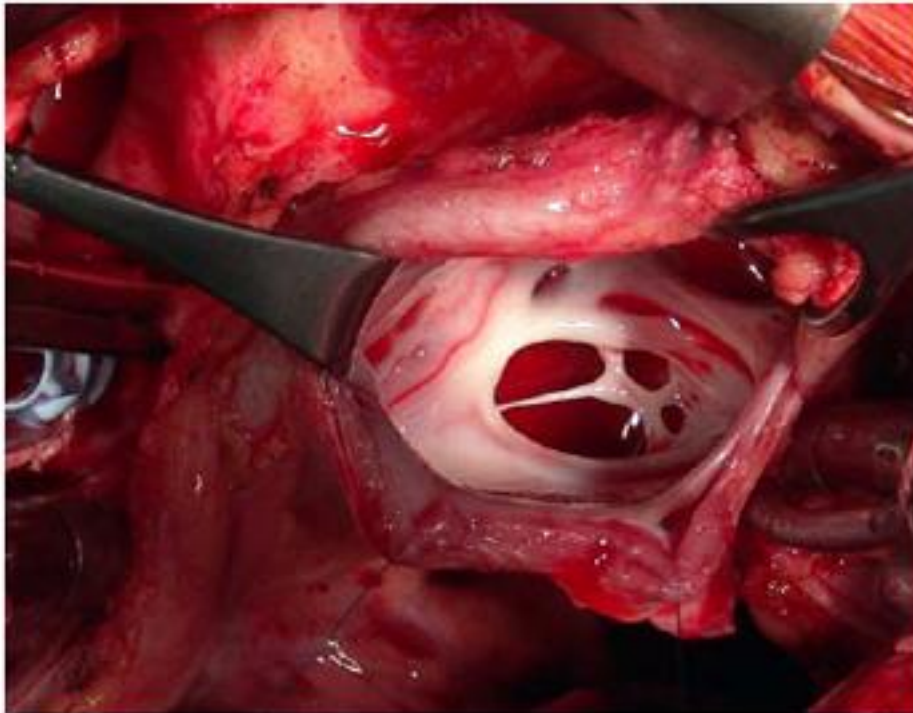
Quel est le diagnostic le plus probable ?

1. Insuffisance tricuspидienne
2. Sténose mitrale
3. Sténose aortique
4. Communication inter-auriculaire type ostium secundum
5. Sténose pulmonaire

Réponse correcte

☐

Vignette 10 - 3



Vignette 11

Un patient de 45 ans présente des douleurs rétrosternales très intenses depuis 4 heures. On diagnostique à l'admission à l'hôpital un infarctus aigu du myocarde dans le territoire antérieur. Le patient est hypotendu à 80 mmHg de systolique et bradycarde à 40 battements par minutes. Quelle est la mesure invasive la plus urgente à pratiquer ?

1. Trombolyse intraveineuse
2. Angioplastie primaire
3. Contrepulsion aortique
4. Transplantation cardiaque
5. Assistance ventriculaire gauche

Réponse correcte

☐

Vignette 12

Un patient sous anticoagulant présente une baisse de l'état général, une hypotension artérielle, une dyspnée et une turgescence jugulaire. A l'auscultation cardiaque, les bruits sont diminués. Un ECG montre des micro-voltages dans les dérivations périphériques. Quel est l'examen de choix pour poser un diagnostic ?

1. Scintigraphie myocardique
2. Echocardiographie
3. Coronarographie
4. Ergométrie
5. Résonnance magnétique cardiaque

Réponse correcte

☐

Vignette 13

Une patiente souffre d'une sténose mitrale post rhumatismale avec une hypertension pulmonaire qui nécessite des investigations avant une intervention. A la radiographie du thorax, on constate une importante cardiomégalie.

Toutes ces trouvailles sont présentes lors d'une sténose mitrale avec hypertension pulmonaire, sauf une, laquelle ?

1. Dilatation de l'oreillette gauche
2. Agrandissement des hiles pulmonaires
3. Dilatation du ventricule gauche
4. Dilatation du ventricule droit
5. Horizontalisation de la bronche souche gauche

Réponse correcte

☐

Vignette 14

Quatre jours après avoir été hospitalisée pour infarctus inférieur aigu du myocarde, une patiente ressent subitement une dyspnée aiguë sans douleurs thoraciques.

On ausculte un gros souffle systolique nouveau au foyer mitral.

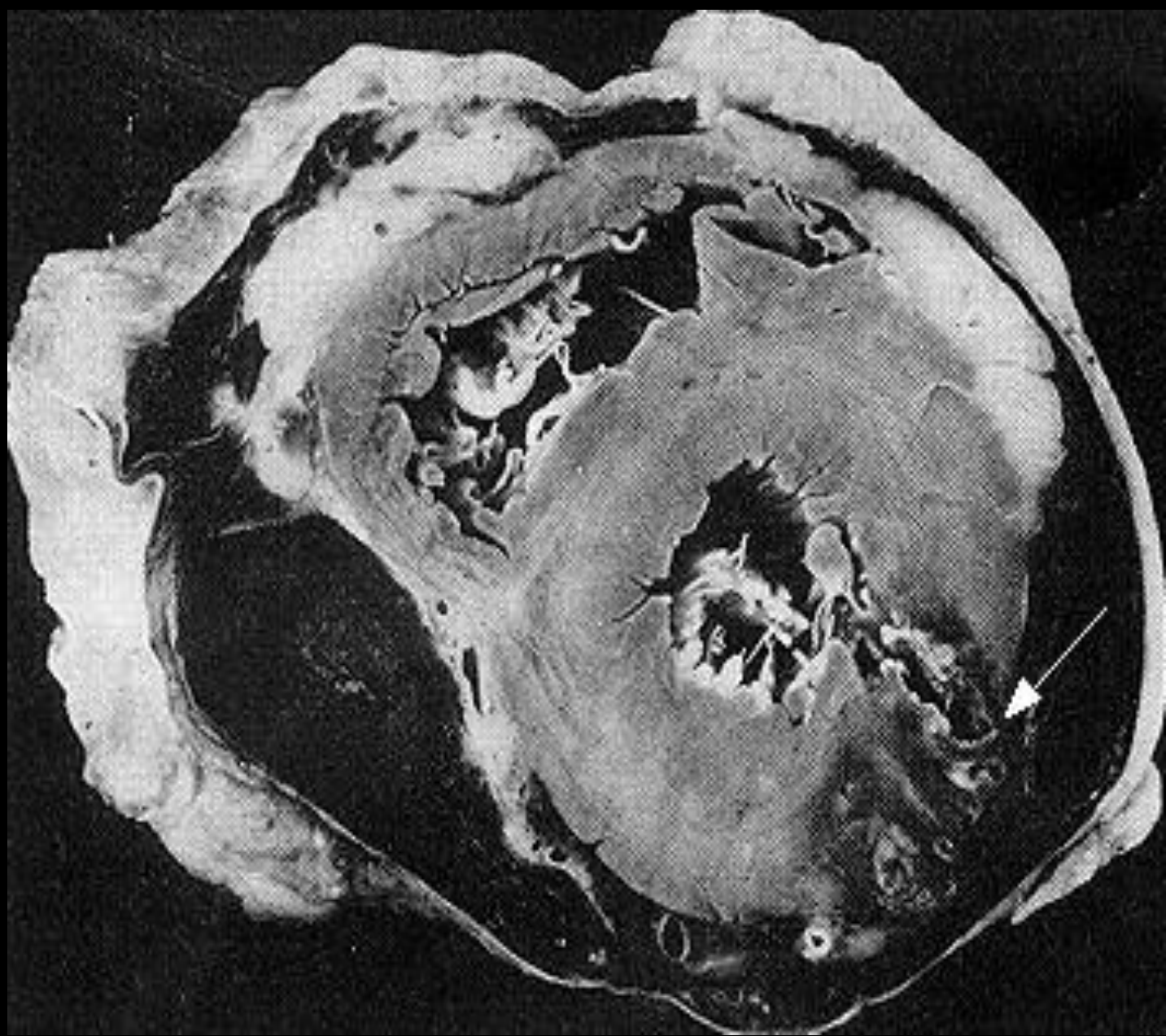
Les saturations de l'hémoglobine lors du cathétérisme droit sont normales.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

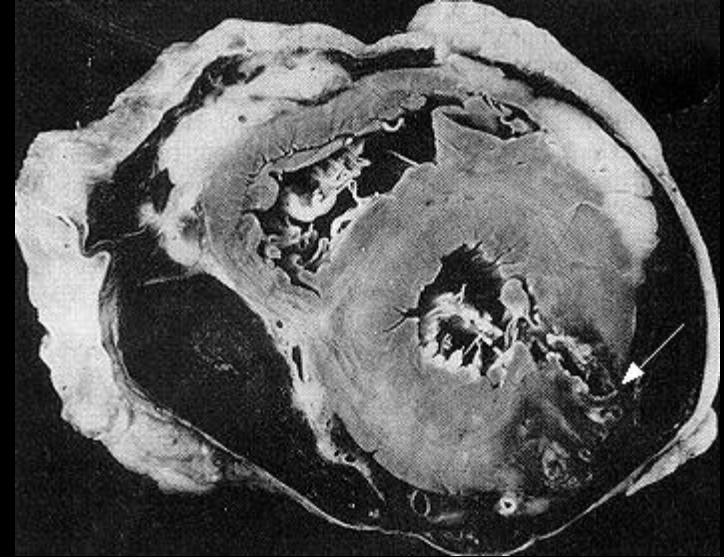
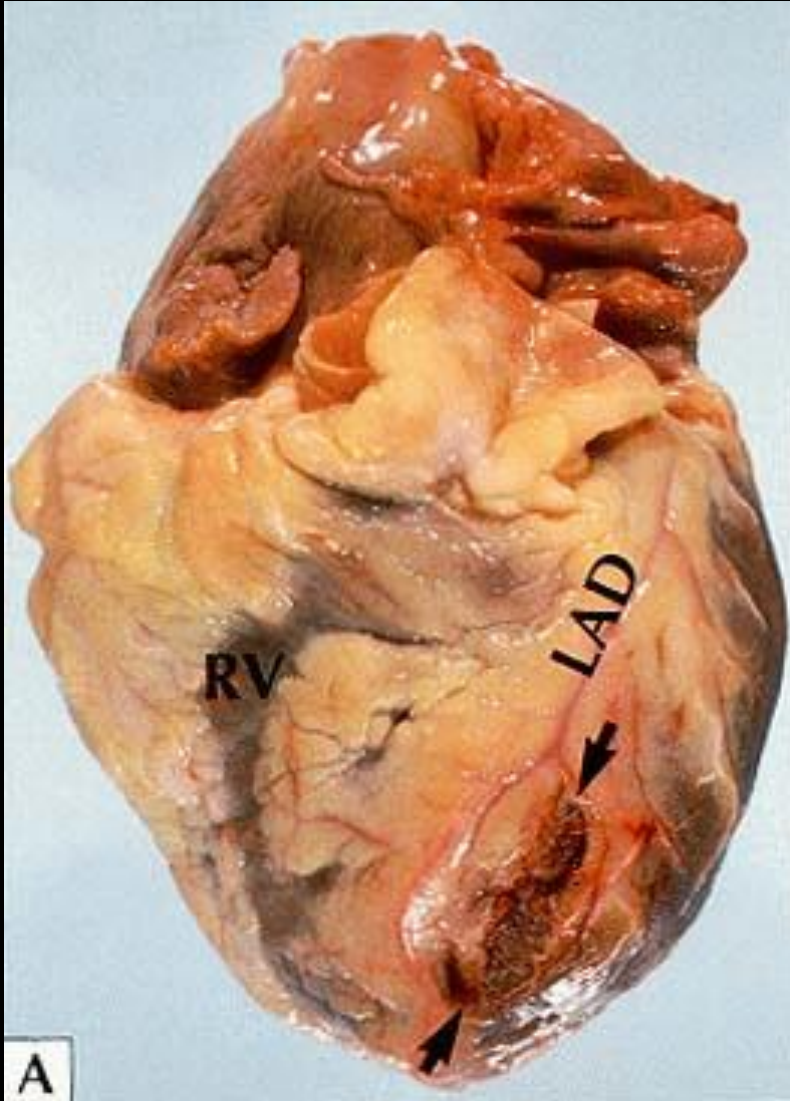
1. Dissection aortique
2. Rupture cardiaque avec tamponnade
3. Perforation du septum interventriculaire
4. Rupture d'un pilier mitral
5. Embolie pulmonaire

Réponse correcte

☐



Rupture myocardique en paroi libre



Rupture en paroi libre



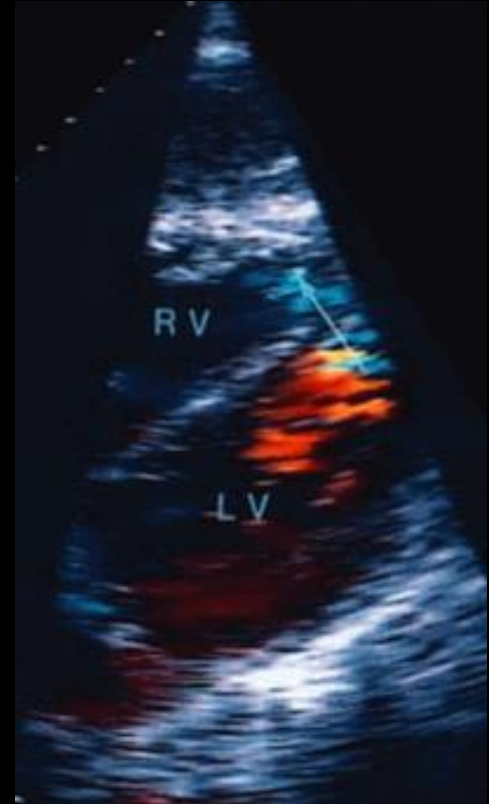
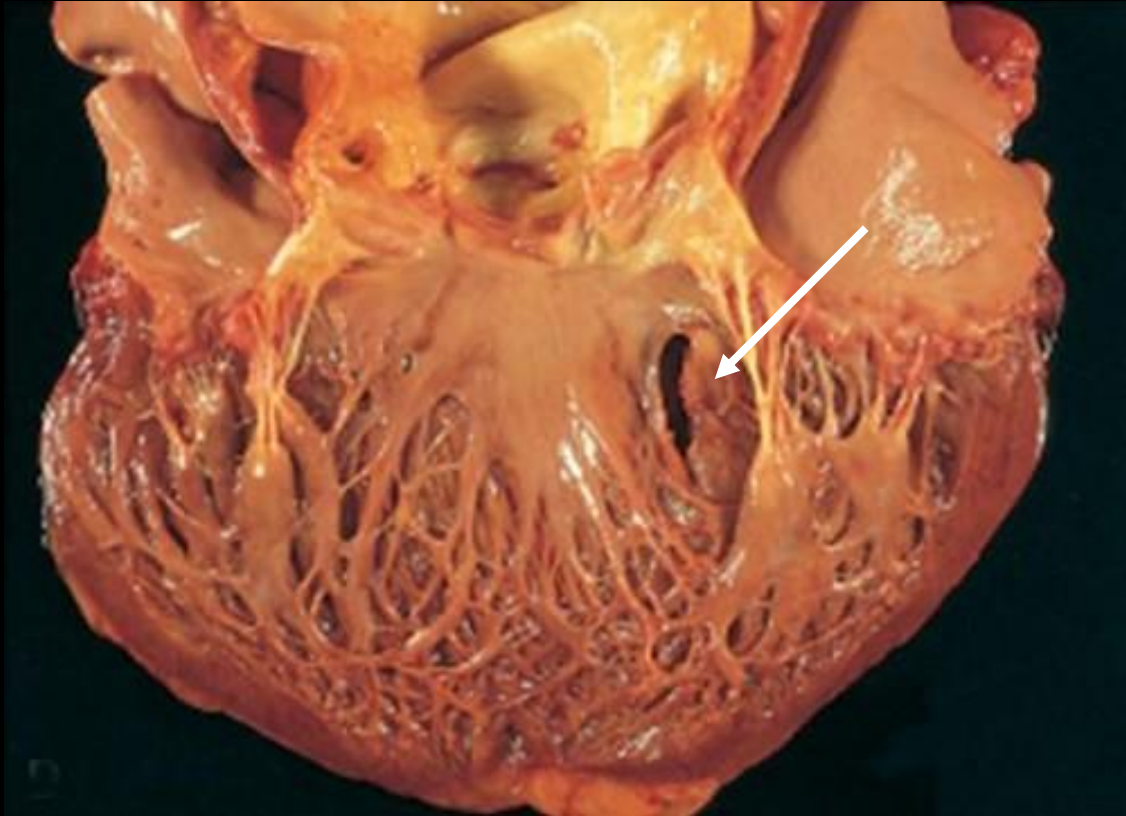
Tamponnade cardiaque



Décès

Modifié selon E. Braunwald

Rupture septale (septum interventriculaire)



Modifié selon E. Braunwald

Rupture du septum IV → shunt gauche droit surcharge cardiaque droite

Rupture de pilier mitral

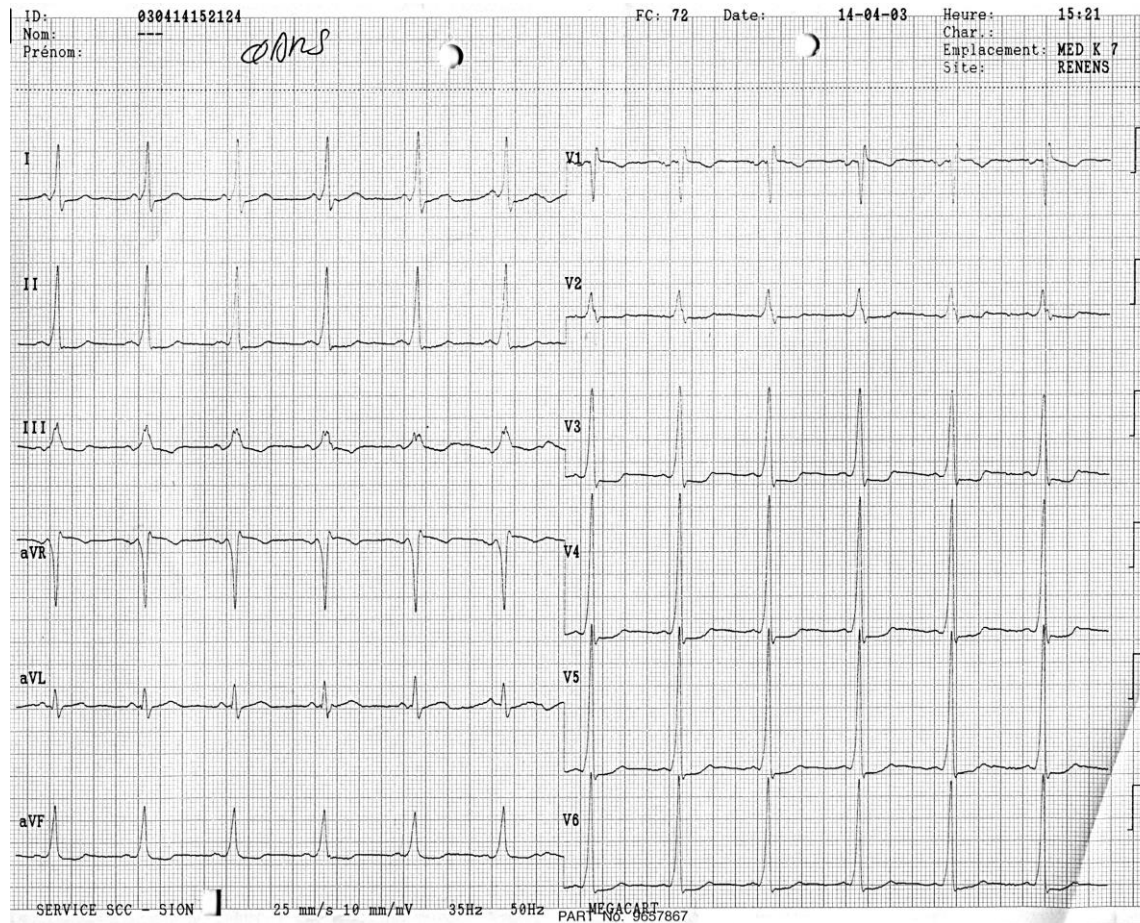


Modifié selon E. Braunwald

Rupture de pilier mitral — insuffisance mitrale aiguë — œdème pulmonaire

Un patient de 30 ans est hospitalisé en urgence pour une syncope.
Il présente depuis 5 ans des épisodes de palpitations, certains associés à des vertiges. Voici son tracé ECG au repos.
Quel est votre diagnostic ?

Vignette 15 - 2



1. Bloc de branche gauche
2. Syndrome de Wolf-Parkinson-White
3. Bloc de branche droit
4. Ischémie antérieure
5. Infarctus postérieur ancien

Réponse correcte

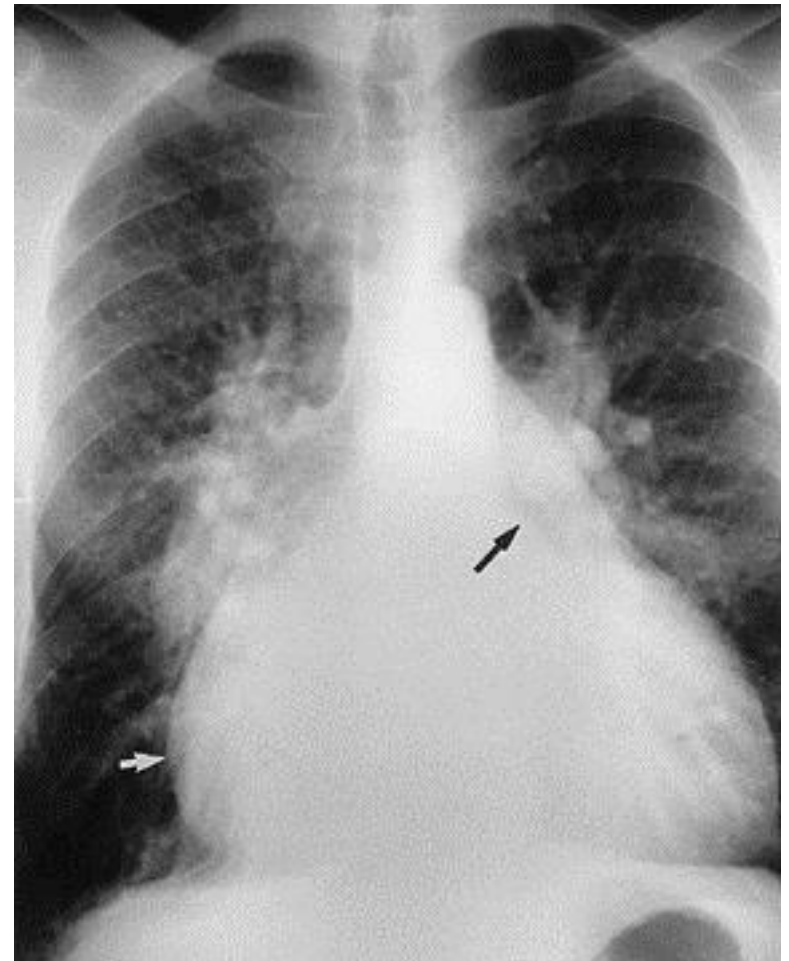


Vignette 16

Patiente de 58 ans admise pour un pré-oedème pulmonaire. Angine à répétition durant l'enfance. Roulement diastolique à l'auscultation cardiaque.

Quel diagnostic évoquer avec cette importante cardiomégalie ?

1. Sténose mitrale
2. Embolie pulmonaire
3. Insuffisance tricuspidiennne
4. Infarctus du myocarde
5. Tamponnade cardiaque



Réponse correcte

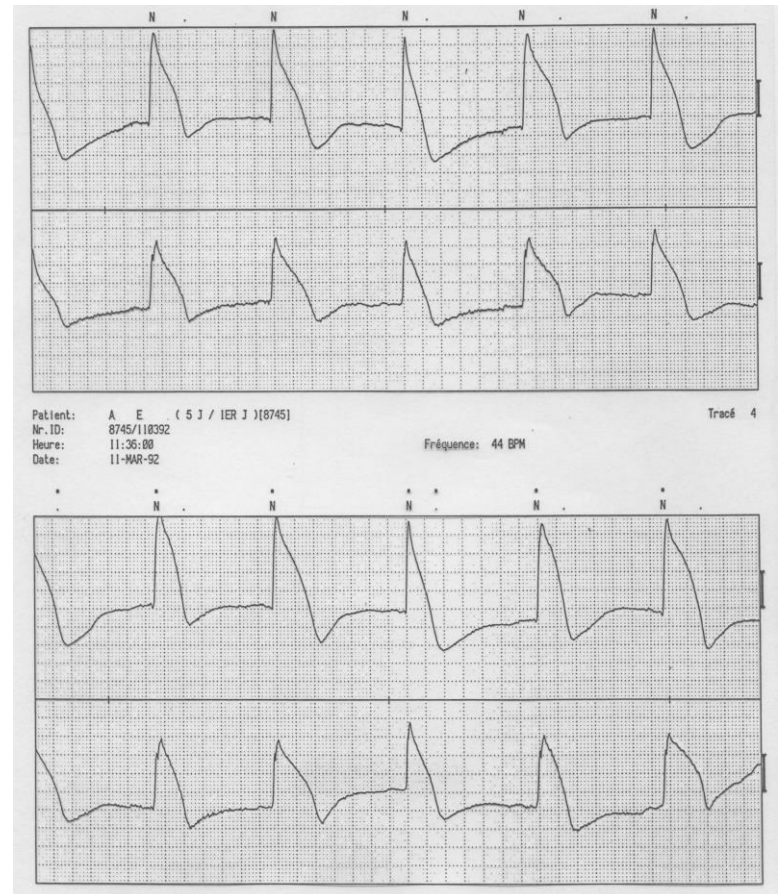


Vignette 17 - 1

Patient de 25 ans, semi-comateux, petits et nombreux hématomes au pli des coudes. Douleurs thoraciques intenses depuis 30 minutes. On pratique un ECG. Quel diagnostic le plus probable envisager ?

1. Spasme coronarien
2. Hyperkaliémie
3. Hypothermie sévère
4. Artefact d'enregistrement
5. Bloc AV complet

Réponse correcte



Quel traitement en urgence vous semble le plus indiqué chez ce patient ?

1. Atropine iv
2. Aspirine per os
3. Nitroglycérine sublingual
4. Béta-bloqueur
5. Pacemaker provisoire

Réponse correcte

☐

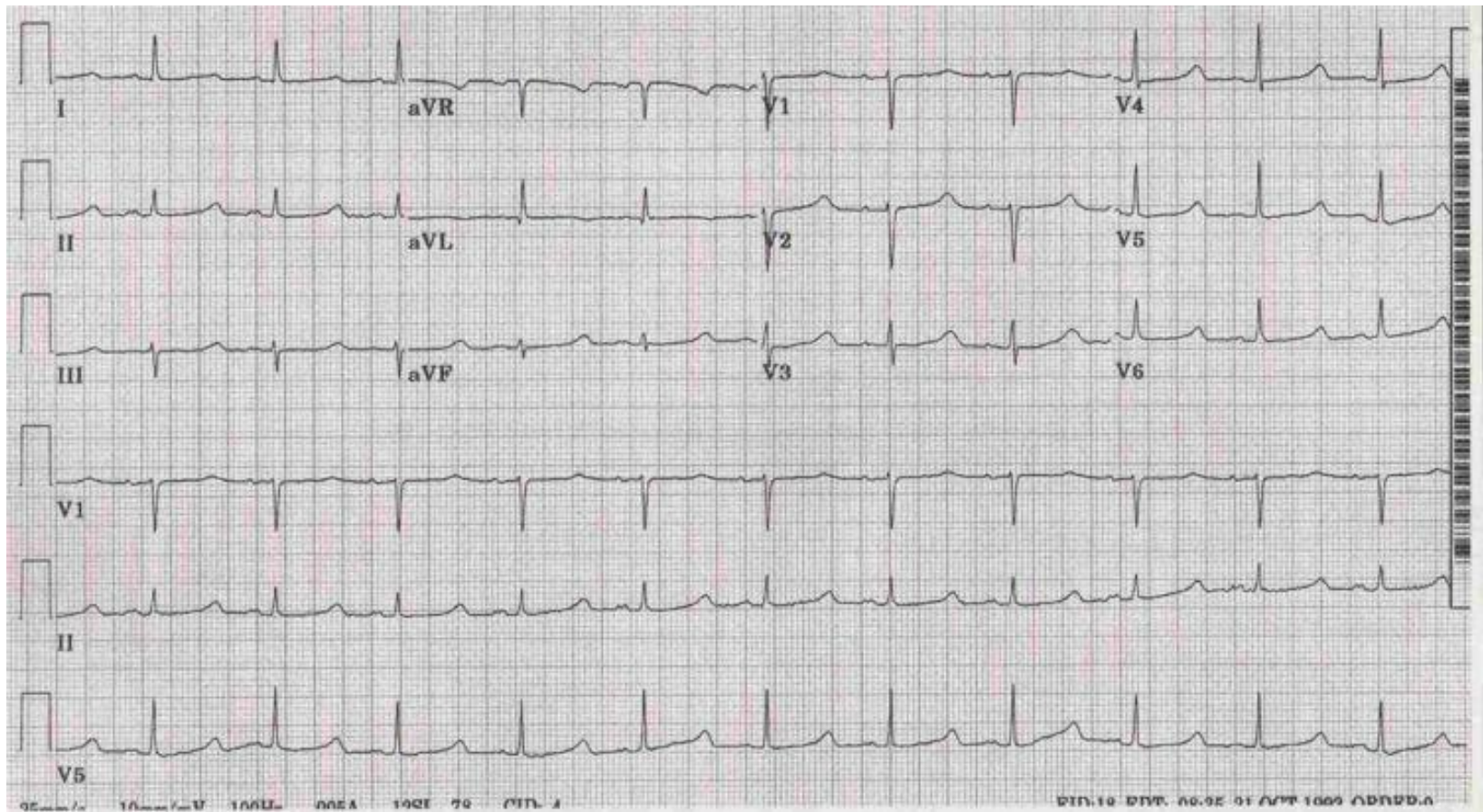
Vignette 18 - 1

Une patiente de 89 ans, diabétique, est hospitalisée pour un malaise avec perte de connaissance.

Son traitement actuel comprend : antidiabétiques oraux, quinidine et digoxine.

Voici l'ECG à l'admission. Quel est votre diagnostic ?

Vignette 18 - 2



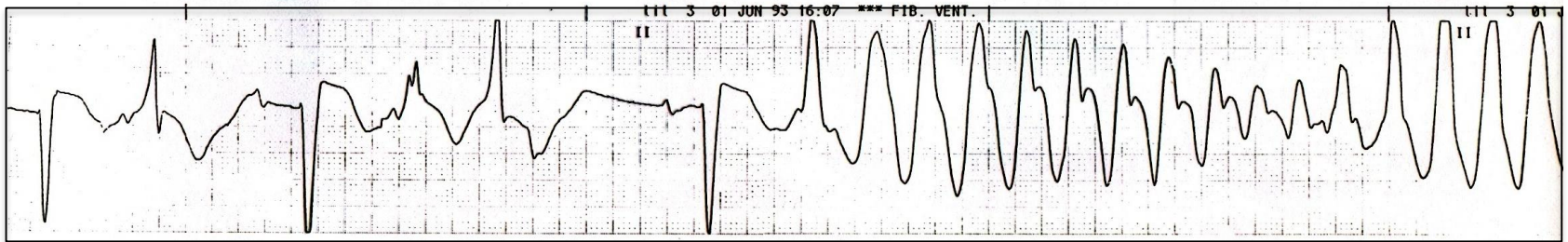
1. Bloc de branche droit
2. QT long
3. Infarctus antérieur ancien
4. HBAG
5. Ischémie latérale

Réponse correcte



Vignette 18 - 3

Peu de temps après son admission, la patiente perd connaissance.
Quel est votre diagnostic ?



1. Fibrillation ventriculaire
2. Fibrillation auriculaire
3. Syndrome de Wolf-Parkinson-White
4. Torsade de pointe
5. Tachycardie nodale

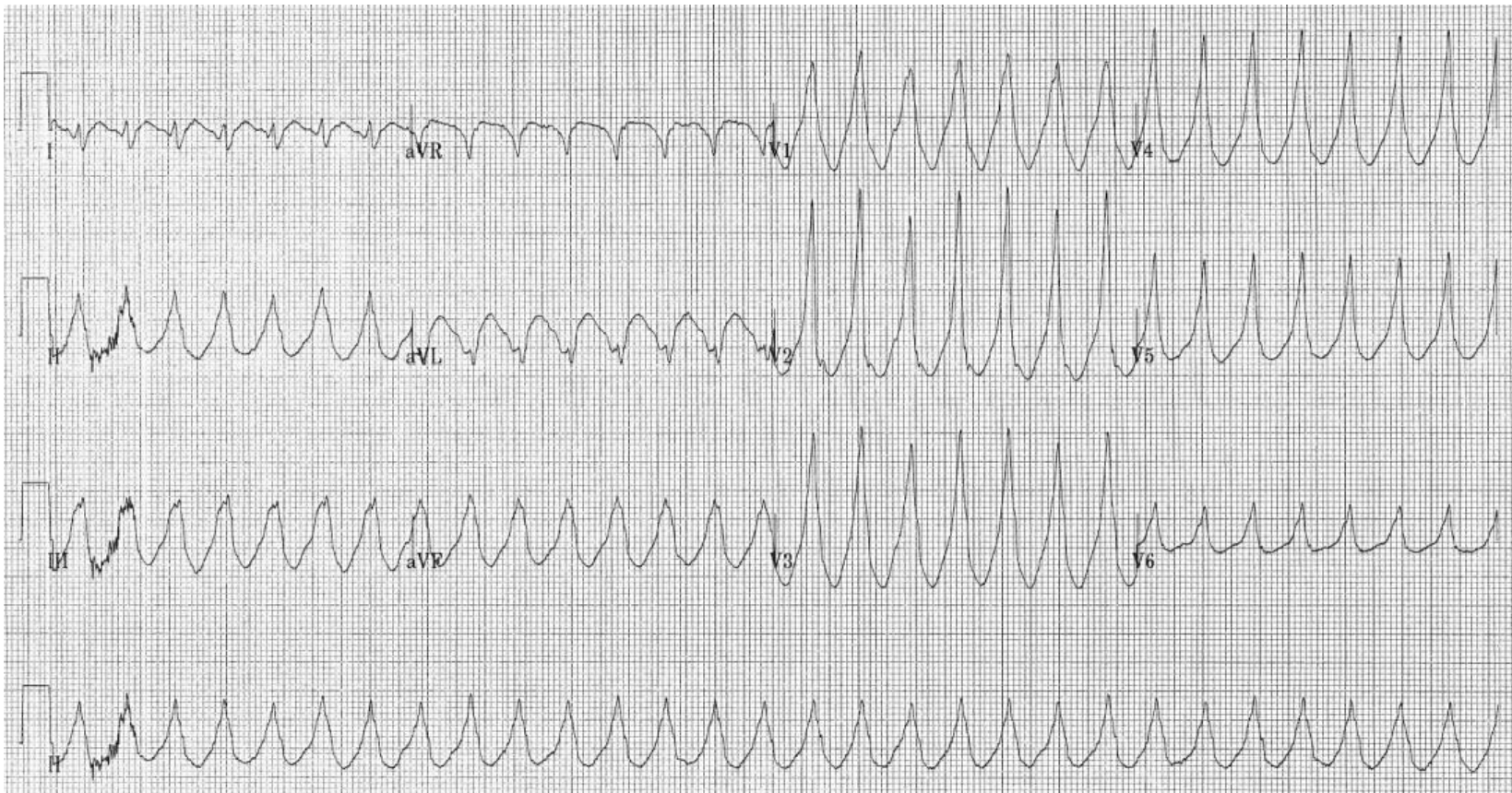
Réponse correcte

☐

Vignette 19

Patient ayant fait un arrêt cardio-respiratoire en cultivant son jardin.
A ressenti des douleurs épigastriques fluctuantes avec sudations peu
auparavant. Vomissement. Le SMUR arrive et trouve un patient conscient
avec un pouls rapide et une tension artérielle de 80 mmHg de systolique.
On pratique un ECG.
Quel diagnostic posez-vous ?

Vignette 19



1. Tachycardie ventriculaire
2. Fibrillation auriculaire
3. Angor de Prinzmetal
4. Flutter auriculaire
5. Fibrillation ventriculaire

Réponse correcte



Réponses Vignettes Cardio

Vignettes	Réponses correctes
-----------	--------------------

Vignette 1	4
Vignette 2	3
Vignette 3	4
Vignette 4	4
Vignette 5	5
Vignette 6	2
Vignette 7	4
Vignette 8	3
Vignette 9	4
Vignette 10	4

Vignettes	Réponse correctes
-----------	-------------------

Vignette 11	2
Vignette 12	2
Vignette 13	3
Vignette 14	4
Vignette 15	2
Vignette 16	1
Vignette 17-1	1
Vignette 17-2	3
Vignette 18-2	2
Vignette 18-3	4
Vignette 19	1